আইনি নোটিশ (ক্ষতিপূরণের দাবি)

ভিকটিমের পিতা কর্তৃক প্রেরিত

প্রেরক: মোঃ শাকিল খান মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)-এর পিতা গ্রাম: কালীগঞ্জ, ডাকঘর: ডাঙ্গাপাড়া (৬৪০০), উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর মোবাইল: ০১৭১৫-২৪১০১৫ / ০১৬১০-০৩৬০০৮

সূত্র নং: SK/NOT/TONNI/2026/01 **তারিখ:** ২৪ অক্টোবর ২০২৬

সরাসরি হস্তান্তর মারফত

প্রাপক: ১. **সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা সিদ্দিকা**, এমবিবিএস, ডিজিও, এফসিপিএস (গাইনী) কনসালট্যান্ট প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, মাদারল্যান্ড ইনফার্টিলিটি সেন্টার ও হাসপাতাল ইব্রাহিম প্লাজা, জিপিও-এর বিপরীতে, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী-৬০০০। (এছাড়াও: সাবেক সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী) ২. **ডা. আর. এ. জালাল**, এমবিবিএস, ডিএ (অ্যানেস্থেসিওলজি) অ্যাটেন্ডিং কনসালট্যান্ট অ্যানেস্থেটিস্ট, মাদারল্যান্ড ইনফার্টিলিটি সেন্টার ও হাসপাতাল ইব্রাহিম প্লাজা, জিপিও-এর বিপরীতে, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী-৬০০০। ৩. **ব্যবস্থাপনা পরিচালক / চেয়ারম্যান** মাদারল্যান্ড ইনফার্টিলিটি সেন্টার ও হাসপাতাল ইব্রাহিম প্লাজা, জিপিও-এর বিপরীতে, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী-৬০০০।

বিষয়: আমার কন্যা মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)-এর ক্ষেত্রে চরম দায়িত্বহীন চিকিৎসাগত অবহেলা, বেপরোয়া কর্তব্য-অবহেলা এবং আজীবন চিকিৎসা ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭,৩৫,০০,০০০/- (সাত কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ) টাকা আদায়ের জন্য টর্টের সাধারণ আইন, দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৩৩৮ ধারা এবং সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে আইনি দাবি-নোটিশ।

মহোদয়,

আমি, **মোঃ শাকিল খান**, **মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)**, বয়স ২৯ বছর, সাং: কালীগঞ্জ, ডাঙ্গাপাড়া, উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর-এর পিতা হিসেবে এই আনুষ্ঠানিক আইনি দাবি-নোটিশ আপনাদের বরাবরে প্রেরণ করছি। আমার কন্যা নিজে কথা বলতে, নড়াচড়া করতে বা কোনো কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম; তাই তার পিতা হিসেবে আমি তার পক্ষে বলছি ও ব্যবস্থা নিচ্ছি।

আপনাদের স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে, আমি এ বিষয়ে বিজ্ঞ আইনজীবীদের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরামর্শ করেছি এবং তাঁদের সুপারিশক্রমেই এই নোটিশ প্রেরণ করা হচ্ছে। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরের জন্য রিট পিটিশনের খসড়া আইনজীবী কর্তৃক পর্যালোচিত ও ইতিমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে। তবে আদালতে যাওয়ার আগে আমি এই নোটিশের মাধ্যমে বিষয়টি সম্মানজনকভাবে মীমাংসার আন্তরিক প্রচেষ্টা করছি — এটাই আমার পরিবারের প্রকৃত ইচ্ছা।

১. ঘটনার পূর্ববর্তী সুস্থতা, সামর্থ্য ও নির্দোষ ভিত্তি

আমার কন্যা মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী) ছিলেন একজন সুস্থ, মেধাবী বিশ্ববিদ্যালয়-স্নাতক — তিনি বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক (বিবিএ) (শিক্ষার্থী আইডি: ১৫৩৪১১০০৯) এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেন এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (বিপিএসসি User ID: CSRUOJUR) অধীনে মর্যাদাপূর্ণ **৪১তম বিসিএস পরীক্ষা ২০১৯**-এ অংশগ্রহণ করেন। বিপিএসসির সরকারি যাচাই নথি (**প্রমাণ-১**) স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তার শরীরের স্বাভাবিক সুস্থ ওজন ছিল **৫০ কেজি**, উচ্চতা ১৫৭ সেমি, এবং তার শারীরিক, স্নায়বিক বা দীর্ঘমেয়াদি **কোনো প্রতিবন্ধিতাই ছিল না**।

২. ভর্তি ও বাধ্যতামূলক অপারেশন-পূর্ব প্রটোকলের চরম লঙ্ঘন

গত **২৪ জুলাই ২০২৩** তারিখে আমার কন্যা পরিকল্পিত সিজারিয়ান অপারেশনের (LUCS) জন্য ৩ নম্বর প্রাপকের ক্লিনিকে ১ নম্বর প্রাপকের সরাসরি চিকিৎসাধীনে ভর্তি হন। অপারেশনের আগে ২ নম্বর প্রাপক চিকিৎসা-মানের সম্পূর্ণ বেপরোয়া অবহেলায় স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া (সাব-অ্যারাকনয়েড ব্লক / SAB) প্রয়োগ করেন। অফিসিয়াল **"Preanaesthetic Assessment" ফর্মটি (প্রমাণ-২) একশো ভাগ ফাঁকা** রাখা হয়েছে — তাতে কোনো প্রাণ-নির্দেশক (ভাইটাল সাইন) নেই, রক্তচাপের কোনো রেকর্ড নেই, শ্বাসনালীর কোনো মূল্যায়ন (Mallampati score) নেই, হৃদ্‌যন্ত্র-ফুসফুসের কোনো পরীক্ষা নেই এবং কোনো চিকিৎসকের স্বাক্ষরও নেই। প্রি-অ্যানেস্থেটিক মূল্যায়ন ছাড়া স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া প্রাথমিকভাবেই চরম ও আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য অবহেলা — এ নিয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ মতামতেরও প্রয়োজন পড়ে না; **আপনাদের নিজস্ব ফাঁকা ফর্মটিই নিজে কথা বলে (Res Ipsa Loquitur)**।

৩. অ্যানেস্থেসিয়াজনিত বিপর্যয়, ফুসফুসে পানি ও পরিত্যক্ত রেকর্ড

২৪ জুলাই ২০২৩ বিকাল প্রায় ৪:০০ টায় স্পাইনাল ইনজেকশনের ঠিক পরপরই আমার কন্যার তীব্র খিঁচুনি, শ্বাসরোধ ও ভয়াবহ হৃদ্‌বিপর্যয় শুরু হয়। ৩ নম্বর প্রাপকের ক্লিনিক — একটি বিশেষায়িত ফার্টিলিটি ডে-ক্লিনিক — যার নিজস্ব নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (ICU), ধমনির রক্ত-গ্যাস পরিমাপ বা যান্ত্রিক ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা ছিল না, এই অপারেশন-কালীন বিপর্যয় সামাল দেওয়ার কোনো সক্ষমতাই রাখত না।

৩ নম্বর প্রাপকের নিজস্ব অফিসিয়াল **মেডিসিন চার্ট (প্রমাণ-৩)** অনুযায়ী নার্সিং কর্মীরা বারবার শিরায় **ল্যাসিক্স (ফুরোসেমাইড)** ও **ল্যাবেকার্ড (ল্যাবেটালল)** ইনজেকশন দেওয়ার রেকর্ড রেখেছেন — যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, অপ্রস্তুত অপারেশন থিয়েটারে তাঁরা তীব্র ফুসফুসে পানি (Acute Pulmonary Edema) ও মারাত্মক উচ্চ রক্তচাপ (১৮০/১২০ মিমি) সামলাতে মরিয়া চেষ্টা করছিলেন। নিজেদের দায় এড়াতে ১ ও ২ নম্বর প্রাপক **অপারেশন নোটটি (প্রমাণ-৪) বাক্যের মাঝখানে ছেড়ে দেন** ("*After SAB, abnormal contraction occurs & then…*") এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তাতে স্বাক্ষর করেননি।

৪. দুই ঘণ্টার বিপজ্জনক বিলম্ব ও ভয়াবহ অক্সিজেন-সংকট

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের স্বীকৃত মান ও প্রটোকল অনুযায়ী অপারেশন-কালীন অক্সিজেন-সংকটে পড়া রোগীকে অবিলম্বে টারশিয়ারি আইসিইউতে স্থানান্তর করা আবশ্যক ছিল। তার বদলে প্রাপকেরা বিপর্যয়টি ধামাচাপা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টায় আমার শ্বাসরুদ্ধ, খিঁচুনিগ্রস্ত কন্যাকে **প্রায় দুই ঘণ্টা আটকে রাখেন**।

স্বতন্ত্র **ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (IBMCH)-এর আইসিইউ ট্রান্সফার নোট (প্রমাণ-৫)** অনুযায়ী আমার কন্যা যখন আইবিএমসিএইচ আইসিইউতে পৌঁছান, তখন তাঁর অবস্থা ছিল অপরিবর্তনীয় ও মুমূর্ষু: * লিপিবদ্ধ ইতিহাস: "*H/O LUCS about* 2 *hours back*" এবং "*Involuntary jerky movement of the body for about* 1 *hour*." * পৌঁছানোর সময় অক্সিজেনের মাত্রা: হাতে অ্যাম্বু ব্যাগ চালিয়েও **SpO2 < 28%** (কার্যত শূন্য অক্সিজেন সরবরাহ)। * রক্তচাপ: **১৮০/১২০ মিমি** (কুশিং ঘটনা / মস্তিষ্কে চরম চাপ)। * স্নায়বিক অবস্থা: **GCS E4 V-T M1 (শিথিল পেশী-পক্ষাঘাত)**। * চোখের পরীক্ষা: **দুই চোখের মণি স্থির, প্রসারিত ও আলোতে অনুভূতিহীন (মস্তিষ্কের গুরুতর ও অপরিবর্তনীয় ক্ষতির সুস্পষ্ট লক্ষণ)**। * হৃদ্‌রোগ নির্ণয়: **NSTEMI** (অক্সিজেন-সংকটজনিত হার্ট অ্যাটাক)।

৫. মস্তিষ্কের অপরিবর্তনীয় ধ্বংস ও জীবন-বিধ্বংসী ক্ষতি

SpO2 < 28%-এ দীর্ঘক্ষণ অক্সিজেন-বঞ্চনা আমার কন্যার মস্তিষ্কে ব্যাপক ও অপরিবর্তনীয় **হাইপোক্সিক-ইসকেমিক এনসেফালোপ্যাথি (HIE)** ও ব্যাপক কর্টিক্যাল ধ্বংস ঘটিয়েছে। বিগত ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি উদ্ভিদ-সদৃশ (ভেজিটেটিভ), বিছানাগত অবস্থায় আছেন। মস্তিষ্কে পানি জমায় (হাইড্রোসেফালাস) **১৮ জানুয়ারি ২০২৫** তারিখে **ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল (NINS), ঢাকা**-তে তাঁর মাথায় বড় নিউরোসার্জারির মাধ্যমে **ভিপি শান্ট (VP Shunt)** স্থাপন করা হয়। **৯ মে ২০২৫-এর ব্রেন এমআরআই রিপোর্টে (প্রমাণ-৬)** রামেক রেডিওলজি ও ইমেজিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. হাফিজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যয়ন করেছেন: "*Bilateral chronic hypoxic ischemic encephalopathy with gross cerebral cortical atrophy following CS since* 2023."

আমার কন্যা আজ স্থায়ীভাবে ট্রাকিয়োস্টোমি-নির্ভর, ক্যাথেটার-নির্ভর এবং চরম স্নায়বিক অপুষ্টিতে (নিউরোজেনিক ক্যাকেক্সিয়া) তাঁর ওজন **৫০ কেজি থেকে মাত্র ২৪ কেজিতে** নেমে এসেছে — শরীরের ভরের ৫০%-এরও বেশি ধ্বংস। এছাড়া বিপর্যয়ের দিন জন্ম নেওয়া তাঁর শিশু সন্তানটি সারা জীবন মায়ের যত্ন ও স্নেহ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

৬. সম্মতি অবহেলাকে আড়াল করে না — আইনি অবস্থান স্পষ্টকরণ

আপনারা যেন কোনো ভুল ধারণায় না থাকেন: রুটিন সিজারের জন্য নেওয়া সাধারণ সম্মতি কোনোভাবেই অবহেলার লাইসেন্স নয়। দণ্ডবিধির ৮৮ ধারার সুরক্ষা কেবল সেই কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা **সদিচ্ছায় ও যথাযথ সতর্কতা ও যত্নসহ** করা হয়। একশো ভাগ ফাঁকা প্রি-অ্যানেস্থেটিক ফর্ম, মাঝবাক্যে পরিত্যক্ত ও স্বাক্ষরহীন অপারেশন নোট এবং দুই ঘণ্টার আটক — এই তিনটি তথ্যের কোনোটিতেই "সদিচ্ছা" বা "যথাযথ যত্ন" নেই। অতএব সম্মতির দোহাই দিয়ে এই দায় এড়ানোর কোনো আইনি পথ খোলা নেই। একইভাবে, বিএমডিসির চিকিৎসা নীতিমালার (Code of Medical Ethics) ৫(ক) ধারা অনুযায়ী রোগীর প্রতি কর্তব্যে চরম অবহেলা নিজেই পেশাগত অসদাচরণ, যা নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলের যথেষ্ট কারণ।

৭. প্রমাণ সংরক্ষণের নির্দেশ

আপনাদের নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, এই ঘটনা সংক্রান্ত **সকল মূল চিকিৎসা রেকর্ড, ওটি রেজিস্টার, ওষুধের স্টক রেজিস্টার, সিসিটিভি ফুটেজ ও অভ্যন্তরীণ নথি** সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করবেন। কোনো রেকর্ড ধ্বংস, পরিবর্তন বা জালিয়াতি করা হলে তা পৃথক ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং

আদালত আপনাদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল অনুমান (adverse inference) গ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য, মূল রেকর্ডসমূহের প্রতিলিপি ইতিমধ্যে আমাদের সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে।

খাতভিত্তিক ক্ষতিপূরণের দাবি

টর্ট আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক পরোক্ষ দায় (vicarious liability) এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট স্বীকৃত সাংবিধানিক প্রতিকার অনুযায়ী ১, ২ ও ৩ নম্বর প্রাপক যৌথ ও পৃথকভাবে আমার কন্যাকে নিম্নোক্ত খাতে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য:

দাবির খাত	বিবরণ ও হিসাবের ভিত্তি	পরিমাণ (টাকা)
১. অতীত চিকিৎসা ব্যয় (২০২৩–২০২৬)	আইবিএমসিএইচ-তে ১৫ দিনের আইসিইউ, নিনস ঢাকায় নিউরোসার্জারি ও ভিপি শান্ট, ধারাবাহিক ব্রেন এমআরআই, ইইজি, ট্রাকিয়োস্টোমি ব্যবস্থাপনা, জরুরি ভর্তি, ক্যাথেটার সরঞ্জাম এবং ৩৯ মাসের চলমান ওষুধ (১৬৯টি সূচিবদ্ধ রেকর্ডে সম্পূর্ণ নথিভুক্ত)।	**১,৩৫,০০,০০০/-**
২. আজীবন ২৪/৭ চিকিৎসা ও নার্সিং সেবা	আগামী ১৫–২০ বছরের জন্য: দুজন প্রশিক্ষিত সেবক (২৪/৭ পালাক্রমে) মাসে ৫০,০০০/-; ক্লিনিক্যাল খাদ্য, খিঁচুনির ওষুধ ও নিয়মিত অ্যান্টিবায়োটিক মাসে ৩৫,০০০/-; পর্যায়ক্রমিক ভিপি শান্ট সংশোধন, ট্রাকিয়োস্টোমি বদলি ও ইউরোলজিক্যাল চিকিৎসা বছরে ২,০০,০০০/- (মূল্যস্ফীতিজনিত ব্যয়বৃদ্ধি সমন্বয়সহ প্রাক্কলিত)।	**২,৫০,০০,০০০/-**
৩. আজীবন কর্মজীবনের উপার্জন ধ্বংস	মোসাঃ সানজিদা ছিলেন যাচাইকৃত ৪১তম বিসিএস প্রার্থী, বিবিএ স্নাতক ও এমবিএ। তাঁর ৩০ বছরের পেশাজীবন ও উপার্জন-ক্ষমতার সম্পূর্ণ ধ্বংস।	**১,৫০,০০,০০০/-**
৪. সন্তানের মাতৃ-বঞ্চনা ও সাধারণ ক্ষতিপূরণ	শিশু সন্তানের শিক্ষা, পুষ্টি ও মানসিক ভবিষ্যতের জন্য ব্যাপক ট্রাস্ট; চরম যন্ত্রণা, ভোগান্তি, বিকৃতি এবং শরীরের ওজনের ৫২% হারানোর (৫০ কেজি → ২৪ কেজি) সাধারণ ক্ষতিপূরণ।	**২,০০,০০,০০০/-**
সর্বমোট আইনি দাবি	**সাত কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা মাত্র**	**৭,৩৫,০০,০০০/-**

আপস-মীমাংসার আহ্বান

উপরোক্ত সবকিছু সত্ত্বেও, এবং আমার কন্যার পূর্ণ অধিকার ও দাবির কোনো ছাড় না দিয়েই, **বিষয়টি আরও জটিল হওয়ার আগেই আমি আদালতের বাইরে আপস-মীমাংসায় সম্মত আছি**। আমার আন্তরিক পছন্দ এমন একটি মীমাংসা যা আমার কন্যার আজীবন চিকিৎসা ও তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে — দ্রুত ও মর্যাদার সঙ্গে — বহু বছরের বিতর্কিত কার্যক্রমের বদলে। আপনারা যদি এমন শর্তে বিষয়টি মীমাংসা করতে চান, তাহলে **নিম্নোক্ত নোটিশের মেয়াদের মধ্যে** উপরে দেওয়া মোবাইল নম্বরে সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানাচ্ছি। এই আহ্বান

সদিচ্ছায় করা; তবে এটিকে দ্বিধা ভাবা যাবে না। নির্ধারিত মেয়াদে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মীমাংসা-প্রস্তাব না এলে আমি নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব, আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই।

আনুষ্ঠানিক নোটিশের মেয়াদ ও আইনি সতর্কবার্তা

অতএব, আমি এতদ্বারা দাবি করছি যে, এই নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৭ (সাত) দিনের** মধ্যে আপনারা যৌথ ও পৃথকভাবে উপরোক্ত **৭,৩৫,০০,০০০/- (সাত কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ) টাকা** ভিকটিমের পক্ষে ও তাঁর কল্যাণের জন্য তাঁর পিতা **মোঃ শাকিল খান**-এর কাছে পে-অর্ডার / ব্যাংক ড্রাফট মারফত পরিশোধ/ জমা করবেন।

আরও জ্ঞাত থাকুন যে, নির্ধারিত ৭ দিনের মধ্যে এই দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, আইনজীবীদের পরামর্শক্রমে আমি আর কোনো পূর্ব-ঘোষণা ছাড়াই আপনাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত আইনি প্রতিকারসমূহ গ্রহণে বাধ্য হবো:

1. **হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন:** বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে আপনাদের ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রস্তুতকৃত রিট পিটিশন দায়ের — উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং একটি স্বাধীন জাতীয় মেডিকেল বোর্ড গঠনের আবেদনসহ;
2. **বিএমডিসিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:** বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০-এর ২৩ ধারা অনুযায়ী ১ ও ২ নম্বর প্রাপকের নিবন্ধন বাতিলসহ সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল;
3. **ডিজিএইচএসে নিয়ন্ত্রক বন্ধকরণ:** মেডিকেল প্র্যাকটিস ও প্রাইভেট ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরি (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর ১১ ধারা অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মাধ্যমে ৩ নম্বর প্রাপকের **ক্লিনিক লাইসেন্স বাতিল** এবং একই অধ্যাদেশের ৯ ধারা লঙ্ঘনের (পূর্ণকালীন নিবন্ধিত চিকিৎসক ও নার্স ছাড়া ক্লিনিক পরিচালনা) তদন্তের আবেদন;
4. **ফৌজদারি মামলা:** দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর **৩৩৮ ধারা** (মানবজীবন বিপন্ন করে বেপরোয়া বা অবহেলাপূর্ণ কাজে গুরুতর আঘাত) অনুযায়ী উপযুক্ত ফৌজদারি আদালতে মামলা — সকল আনুষঙ্গিক খরচ ও পরিণতিসহ ফৌজদারি ও দেওয়ানি দায় আপনাদের ওপর বর্তাবে।

গণমাধ্যম ও জনসচেতনতা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

আরও জ্ঞাত থাকুন যে, এই মামলা এখন আর শুধু একটি পরিবারের ব্যক্তিগত বিষয় নয় — এটি বাংলাদেশের বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় জবাবদিহিতার একটি জাতীয় প্রশ্নে পরিণত হয়েছে:

- আমার কন্যার ঘটনা নিয়ে একটি **তথ্যভিত্তিক ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে**, যা সম্পূর্ণরূপে এই নোটিশে উল্লেখিত চিকিৎসা রেকর্ড ও প্রমাণের ওপর নির্মিত। ফিল্মটির কোনো অংশেই আপনাদের নিজস্ব রেকর্ড যা প্রমাণ করে তার বাইরে একটি শব্দও নেই।
- ফিল্মটি **রিট পিটিশন দায়েরের পরদিন** জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল, জাতীয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মসহ **৩০টিরও বেশি গণমাধ্যমে সারাদেশে একযোগে প্রকাশের** জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

- সম্পূর্ণ ১৬৯টি মেডিকেল রেকর্ডের একটি **উন্মুক্ত ডিজিটাল প্রমাণ-আর্কাইভ** ইতিমধ্যে সর্বজনীনভাবে যাচাইযোগ্য অবস্থায় রয়েছে; দেশের যেকোনো সাংবাদিক, চিকিৎসক বা নাগরিক নিজে তা পরীক্ষা করতে পারেন।
- আমার কন্যা একা নয়: **তার সহপাঠী ও সহশিক্ষার্থীরা তার ও আমাদের পরিবারের পাশে আছে, এবং তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ — রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, নবাব সিরাজউদ্দৌলা সরকারি কলেজ এবং তার হাই স্কুল — ন্যায়বিচারের দাবিতে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।**
- আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমকর্মীরা ইতিমধ্যে পরিবারের সাক্ষাৎকার ও ঘটনাস্থল-ভিত্তিক প্রতিবেদনের জন্য যোগাযোগ করেছেন; রিট দায়েরের দিন থেকে সেই প্রচার পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে।

স্পষ্ট করে জানাচ্ছি: এই জনসচেতনতামূলক প্রচার কোনো শর্তের বিনিময়ে থামার বিষয় নয় — এটি জনস্বার্থে একটি তথ্যভিত্তিক উদ্যোগ, যা নিজ গতিতে এগিয়ে যাবে। তবে বিষয়টি আপসে মীমাংসা করা হলে, তা সম্পন্ন হবে পারস্পরিক সম্মান ও পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে — সেটাই আমার পরিবারের আন্তরিক পছন্দ।

এই নোটিশের একটি কপি আইন আদালতে উপস্থাপনের জন্য আমার কাছে সংরক্ষিত রইল।

ধন্যবাদান্তে,

মোঃ শাকিল খান মোসাঃ সানজিদা খাতুন (তন্নী)-এর পিতা মোবাইল: ০১৭১৫-২৪১০১৫ / ০১৬১০-০৩৬০০৮

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য): ১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS), মহাখালী, ঢাকা। ২. রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (BMDC), বিজয় নগর, ঢাকা। ৩. সিভিল সার্জন, রাজশাহী।

সংযুক্তি (প্রমাণের তালিকা): প্রমাণ-১: বিপিএসসি আবেদন ও স্বাস্থ্য-যাচাই নথি (সুস্থতার সরকারি বেসলাইন) | প্রমাণ-২: ১০০% ফাঁকা প্রি-অ্যানেস্থেটিক মূল্যায়ন ফর্ম | প্রমাণ-৩: মাদারল্যান্ডের মেডিসিন চার্ট | প্রমাণ-৪: অসমাপ্ত ও স্বাক্ষরহীন অপারেশন নোট | প্রমাণ-৫: IBMCH আইসিইউ ট্রান্সফার নোট (৩ পৃষ্ঠা) | প্রমাণ-৬: ব্রেন এমআরআই রিপোর্ট ও প্রত্যয়ন (৯ মে ২০২৫) | প্রমাণ-৭: রোগীর সুস্থ অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার ছবি। (ডিজিটাল আর্কাইভে সংশ্লিষ্ট ফাইল নম্বরসমূহ যথাক্রমে: IMG_0048, IMG_9906, IMG_9908, IMG_9905, IMG_9890–9892, IMG_9994 — নিচের লিংকে প্রতিটি রিপোর্ট মিলিয়ে দেখা যাবে।)

সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্রমাণ-আর্কাইভ: উপরোক্ত সকল প্রমাণসহ সম্পূর্ণ মেডিকেল রেকর্ডের মূল ছবি যাচাইয়ের জন্য সংরক্ষিত আছে — https://github.com/alphafhb/bangladeshi-medical-trap